

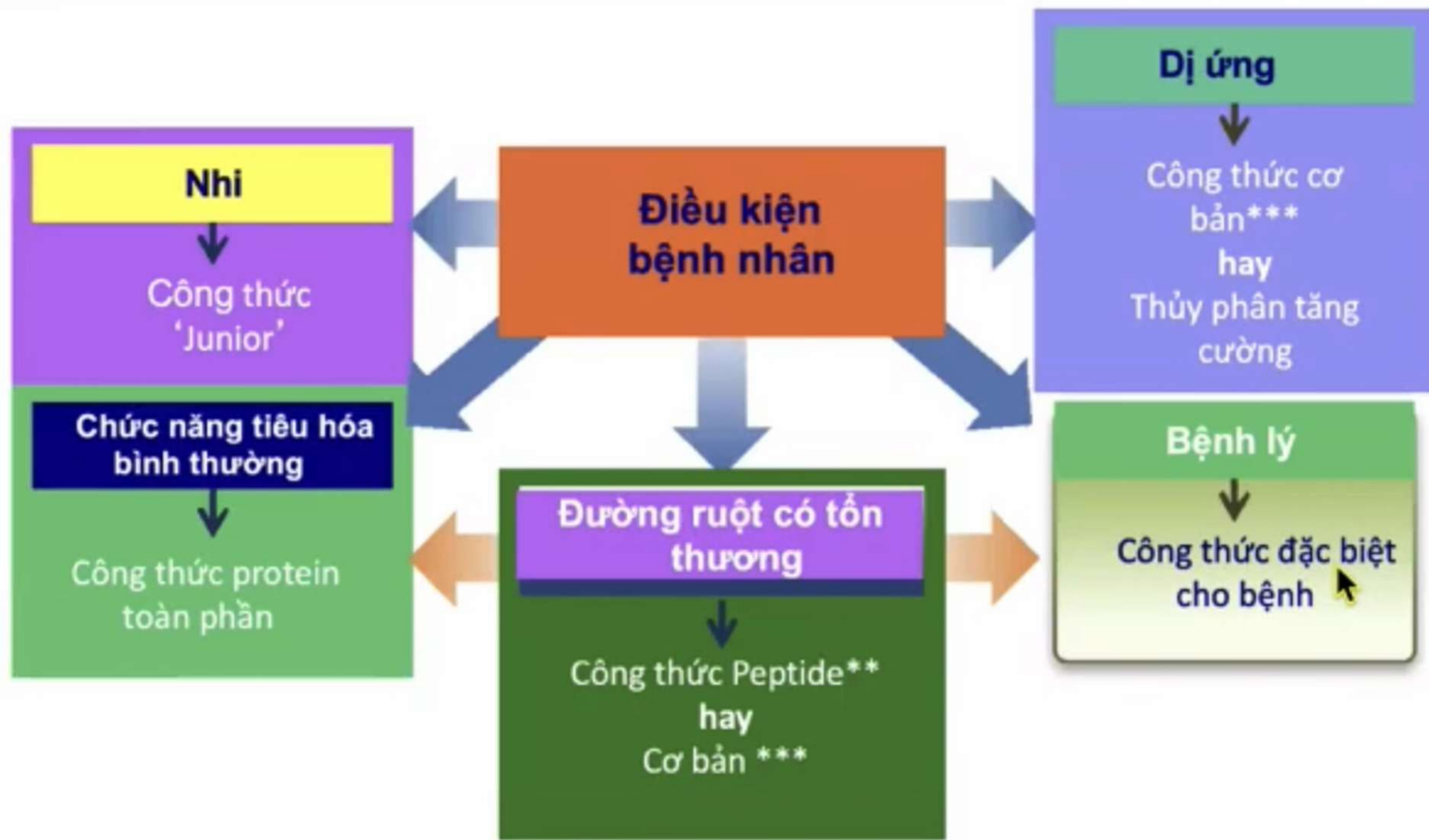


NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN TRONG MỘT SỐ BỆNH



TS.BS. Nguyễn Thị Thuý Hồng
BM Nhi – ĐHY Hà Nội

KHI NÀO ? DÙNG CÔNG THỨC DINH DƯỠNG GÌ ???



***Amino acid formula

CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ DINH DƯỠNG



NUÔI ĂN TĨNH MẠCH

NUÔI ĂN ĐƯỜNG RUỘT

**BỔ SUNG DINH DƯỠNG
ĐƯỜNG MIỆNG**

TỰ VẤN DINH DƯỠNG

Can thiệp dinh dưỡng nên tăng cường từng bước tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tình trạng cơ bản và tình trạng suy dinh dưỡng

NỘI DUNG

1

Dinh dưỡng trong bệnh tiêu chảy

2

Dinh dưỡng trong hội chứng kém hấp thu

3

Dinh dưỡng trong bệnh thận

4

Dinh dưỡng trong bệnh gan

5

Dinh dưỡng trong bệnh tiểu đường

NỘI DUNG



Diarrhea

1

DINH DƯỠNG TRONG BỆNH TIÊU CHẢY

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH TIÊU CHẢY CẤP

✓ Nguyên tắc:

- Tăng cường nước: 130-150ml/kg/ngày.
- Độ đậm NL:
 - + Thấp: trong những ngày đầu.
 - + Tăng dần: 100 kcal/kg/ngày (sau 1 tuần).
- Thành phần các chất dinh dưỡng:
 - + Protid: Ưu tiên đạm động vật.
 - + Lipid: Đảm bảo đủ nhu cầu và sử dụng dầu thực vật.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH TIÊU CHẢY CẤP

✓ Nguyên tắc (Tiếp)

- Glucid:
- + Giảm tỉ lệ chất xơ.
- + Giảm lượng đường đơn đặc biệt là đường lactose.
- + Giảm ALTT.
- Sử dụng TP giàu muối khoáng, đặc biệt nhiều Kali (chuối).
- Thực phẩm giàu VTM (VTM A).
- Thực phẩm giàu kẽm (thịt gà, thịt bò,...).

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH TIÊU CHẢY CẤP

✓ Chế độ ăn:

- Thức ăn mềm, nhuyễn, loãng hơn, dễ tiêu hoá.
- Chia nhỏ nhiều bữa ăn trong ngày. Làm loãng thức ăn (cháo, bột).
- Tiếp tục duy trì sữa mẹ.
- Đối với trẻ ăn sữa CT: Sử dụng sữa Free lactose.
- *Khi trẻ khỏi bệnh: Ăn tăng thêm 1 bữa (trong 2 tuần).*

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH TIÊU CHẢY KÉO DÀI

✓ **Mục tiêu điều trị:**

- Bù nước và điện giải.
- Điều trị theo nguyên nhân.
- Hồi phục đường ruột, giúp trẻ tăng trưởng.

➔ *Chế độ ăn quan trọng, giúp:*

- Phục hồi nhanh chức năng ruột (nhưng mao).
- Giảm tần suất tiêu chảy, tình trạng MN, RLĐG.
- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH TIÊU CHẢY KÉO DÀI

✓ Nguyên tắc:

- Giảm tạm thời: Sữa ĐV (đường lactose) và sucrose.
- Cung cấp đủ: NL, dầu TV, VTM, VCDD (kẽm,...)
- Tránh thức ăn, nước uống làm tăng tiêu chảy (Nhiều chất xơ, đậm độ đường cao).

➔ *Trong giai đoạn hồi phục, cần tăng cường các chất DD.*

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH TIÊU CHẢY KÉO DÀI

✓ Chế độ ăn:

- *Năng lượng: Tăng dần 70 → 100 → 150 kcal/kg/24h.*
- Thức ăn nghiền nhỏ, ninh nhừ.
- Protid:
 - + G/Đ đầu: NL từ Protein = 9% E.
 - + Ưu tiên sản phẩm đạm thủy phân.
- Glucid: Sử dụng sữa Free lactose.
- Lipid: Ưu tiên dầu TV.
- VTM và VCDD: Tăng cường VTM A, K, kẽm,...
- Nuôi dưỡng TM: G/Đ ngắn (2 – 3 ngày đầu).

NỘI DUNG



2

DINH DƯỠNG TRONG HỘI CHỨNG KÉM HẤP THU

NỘI DUNG

3

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG CÁC BỆNH THẬN

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG CÁC BỆNH THẬN

✓ **Nguyên tắc:**

- Năng lượng: 40kcal/kg/24h (trong 1, 2 ngày đầu)
→ Tăng dần theo nhu cầu.
- Hạn chế protein (mức độ vừa phải).
- Hạn chế muối và nước.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ THÔNG THƯỜNG)

✓ Chế độ ăn:

- Muối: Hạn chế tương đối ($1,5-2\text{g}/24\text{h} \approx 600-800\text{mg Na}/24\text{h}$).
Khi trở hết phù tăng dần: $1\text{g}/24\text{h}$).
- Nước: $\text{€} = \text{SL nước tiểu (ngày hôm trước)} + 15\text{ml/kg}/24\text{h}$).
- Hoa quả: Hạn chế hoa quả nhiều kali (chuối).
- Bổ sung VTM (đường uống).

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ THÔNG THƯỜNG)

✓ Chế độ ăn:

- Theo nhu cầu của trẻ.
- Cung cấp đạm (Protein): 0,6-0,8g/kg/24h. *Có thể: ½ sữa bò + ½ sữa đậu nành).*
- Glucid: 5-7g/kg/24h.
- Lipid: 2,5g/kg/24h.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ THÔNG THƯỜNG)

✓ Chế độ ăn:

- Ví dụ: XD khẩu phần ăn cho trẻ 3 tuổi bị VCTC (Thể thông thường).
- Trong 3 ngày đầu: Cho trẻ ăn cháo đường:
 - + Gạo: 50g
 - + Đường: 50g
 - + Dầu: 20g
 - + Muối: 1g
- Sữa bò: 300ml (hoặc 150ml sữa bò + 150ml sữa đậu nành).
- Táo: 100g.
- Nước: 100ml.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ CAO HUYẾT ÁP)

✓ Nguyên tắc:

- Hạn chế nước trong 3 ngày đầu.
- Hạn chế muối tuyệt đối.
- Hạn chế đạm (vừa phải).

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ CAO HUYẾT ÁP)

✓ Chế độ ăn:

- Năng lượng: Đáp ứng nhu cầu theo tuổi (Tăng NL từ chất bột: ngũ cốc, củ). Hạn chế đường (<20g/ngày).
- Protid: Ăn nhiều đạm thực vật.
- + Không suy thận: <10g/ngày (0,8-1g/kg/24h).
- + Suy thận: 0,4-0,6g/kg/24h.
- Lipid: 15-20% E.
- + Nên dùng dầu từ: Cá, đậu nành, lạc vừng,...
- + Hạn chế TP nhiều cholesterol (Phủ tạng ĐV, trứng,...).

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ CAO HUYẾT ÁP)

✓ Chế độ ăn:

- Nước uống: Hạn chế trong 3 ngày đầu.
- + Tổng nước (Uống + CĐ ăn): 600 – 700ml/ngày.
- + Ưu tiên nước rau luộc.
- VTM và khoáng chất:
 - + Ưu tiên VTM tan trong nước (B,C), tan trong dầu (A,E).
 - + Acid Folic.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP (THỂ CAO HUYẾT ÁP)

✓ Chế độ ăn:

Ví dụ: Trong 2-3 ngày đầu khi có HA cao nên cho CĐ ăn khô.

- Trẻ nhỏ:

+ Sữa đậu nành 25% đường: 150ml.

+ Cháo đặc + đường + 10g dầu: 400ml.

+ Chè bột sắn (50g bột + 35g đường) 100ml.

- Trẻ lớn:

+ Nên ăn chế độ ăn khô: cơm, thịt,...

+ Nước quả; 100ml (Không nên ăn canh và uống nhiều sữa).

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP THỂ URE HUYẾT CAO (TIỂU ÍT HOẶC VÔ NIỆU)

✓ Nguyên tắc:

- Năng lượng: 80 – 100% nhu cầu.
- Hạn chế protein.
- Tăng cường NL từ Lipid (30 - 40% E).
- Hạn chế: Na, K, P.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP THỂ URE HUYẾT CAO (TIỂU ÍT HOẶC VÔ NIỆU)

✓ **Chế độ ăn:**

- ***Vô niệu:***

+ **Protid:** Hạn chế tối đa.

+ Lipid: 2,5g/kg/24h.

+ Glucid: 3 – 7g/kg/24h.

+ **Hạn chế muối tuyệt đối. Không thêm muối vào thức ăn.**

+ Nước: 35 – 45ml/kg/24h.

- ***Khi tiểu được:***

+ Tăng dần E lên mức bình thường.

+ Tăng dần: Na, K.

+ Tăng dần Protein: 0,4 → 0,8 → 1 → 1,5g/kg/24h.

CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH VIÊM CẦU THẬN CẤP THỂ URE HUYẾT CAO (TIỂU ÍT HOẶC VÔ NIỆU)

✓ Chế độ ăn:

Ví dụ: Trong những ngày đầu khi BN hôn mê nên cho CĐ ăn qua sode, dung dịch (Đường + Dầu):

- Dầu: 20g
- Protein: 0
- Nước đường 40%: 200ml
- NL: 500 kcal

➔ Khi bệnh nhân tỉnh:

- Cho CĐ ăn: Protid <10g/ngày.
- Tăng dần các thành phần khác.

CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ

✓ Nguyên tắc:

- Năng lượng: Đáp ứng nhu cầu theo tuổi.
- Protid: NCDD (tuổi) + Protein (mất qua NT) + 15-20% NC (Nếu đang điều trị Corticoid).
- Lipid: 10 – 20% E. Cholesterol <200mg/ngày.
- Muối khoáng: Giảm khi phù (1g/24h).

CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ

✓ Chế độ ăn:

- Thực phẩm phù hợp khẩu vị. Hạn chế TP nhiều cholesterol (Tạng ĐV, lòng đỏ trứng,...).
- Không ăn thức ăn sẵn (nhiều muối, mỡ).
- Protid : 2-3g/kg/24h.
- Glucid: 5-7g/kg/24h.
- Lipid: 2g/kg/24h.
- Muối: Na (1g/kg/24h).

NỘI DUNG



4

DINH DƯỠNG TRONG BỆNH GAN

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN VIÊM GAN CẤP (VGSVT)

✓ Mục tiêu điều trị:

➔ *Chế độ ăn quan trọng, giúp:*

- Ngăn ngừa nhiễm mỡ ở gan và ngăn ngừa thoái hoá TB gan (Chế độ ăn ít mỡ, đủ đạm,...).
- Tạo điều kiện để TB gan tái tạo tốt (Cung cấp đủ chất dinh dưỡng, yếu tố vi lượng và VTM).
- Giảm sự làm việc của gan.

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN VIÊM GAN CẤP (VGSVT)

✓ Nguyên tắc:

- Năng lượng: 80 – 100 Kcal/kg/24h.
- ➔ Tăng dần SL khi BN ổn định.
- Tỷ lệ các chất dinh dưỡng: P:L:G.
- Protein: Cần được cung cấp đủ (1,5 – 2g/kg/24h).
- Lipid: Hạn chế (1g/kg/24h).
- Glucid: Nên được tăng cường (6g/kg/24h).

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN VIÊM GAN CẤP (VGSVT)

✓ Chế độ ăn:

- Ăn thức ăn lỏng (cháo, sữa,...).
- Nếu trẻ ăn kém hoặc nôn: Truyền TM Glucose (10%, 20%).
- *Tăng cường Glucid* → Tăng tạo glycogen trong gan → Hạn chế tích mỡ tại gan, ngăn cản xâm nhập độc chất.
- Ăn đủ Protid → Tăng tái tạo TB gan, giảm ngộ độc gan.
- *Hạn chế Lipid* → Giảm thoái hoá mỡ TB gan. Không dùng TĂ giàu cholesterol.
- Giảm muối, tăng cường VTM và VCDD.

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN VIÊM GAN CẤP (VGSVT)

✓ **Ví dụ: Cháo cho BN viêm gan**

- Gạo: 100g
- Thịt bò: 100g
- Muối: Vừa ăn

➔ Cháo viêm gan: 1000ml

P: 28,6g

L : 4,6g

G: 76,2g

NL: 595 kcal.

NỘI DUNG

5

DINH DƯỠNG TRONG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

✓ Mục tiêu điều trị:

➔ *Chế độ ăn quan trọng, giúp:*

- Kiểm soát đường huyết.
- Giúp trẻ tăng trưởng tốt.

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

✓ **Mục tiêu điều trị:**

➔ *Chế độ ăn quan trọng, giúp:*

- Đạt và duy trì:
- + Kiểm soát đường huyết.
- + Khắc phục rối loạn mỡ máu.
- + Kiểm soát huyết áp.
- Phòng ngừa biến chứng mạn tính.
- Cung cấp đủ NCDD (đảm bảo theo sở thích, thuận tiện)

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

✓ Nguyên tắc chung:

- Đảm bảo cung cấp đủ NCNL.
- Đảm bảo lượng đường huyết (4-6 mmol/l), HbA1c (6,5-7%).
- Phòng ngừa biến chứng (vi mạch, mạch máu lớn).T\
- Thực đơn đa dạng, phù hợp (thói quen ăn uống, thuốc đang sử dụng,...).

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

✓ Nguyên tắc:

- Năng lượng = nhu cầu theo lứa tuổi.
- + SDD (Tuổi vị thành niên): Tăng 1,5 – 2 lần.
- + Béo phì: Giảm 5 – 10%.
- Tỷ lệ các chất dinh dưỡng: P:L:G = 10-15%:30-35%:50-60%.

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

✓ Nguyên tắc:

- Protein: Nhu cầu giảm dần theo tuổi. Trẻ lớn < 1,5g/kg/24h.
- + Nhũ nhi: 2g/kg/24h.
- + Trẻ <10 tuổi: 1g/kg/24h.
- + Trẻ vị thành niên: 0,8g/kg/24h.
- Lipid: Acid béo no (<10%)/Acid béo đa nối đôi (<10%)/Acid béo 1 nối đôi (>10%).
- Glucid: Đường đơn <10% E.
- Chất xơ: 1,5 – 2,5g/100kcal.
- Hạn chế muối (<6g/24h).

CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

✓ Chế độ ăn:

- Tùy theo nhu cầu và sở thích (sữa, cơm, cháo,...).
- *Tăng cường thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (đường phức tạp polymeglucose)*
- Hạn chế TP khô, đóng hộp, rau củ muối.
- Nếu trẻ có điều trị Insulin → Ăn thêm 2 bữa phụ.
- Sắp xếp giờ ăn thích hợp để tiêm Insulin.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

